

Manual de historia clínica, registros y conservación

Manual | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Mantener una historia única, íntegra, cronológica, reservada y con autoría válida de cada atención.

2. Alcance y condiciones de uso

Historia física o electrónica de fisioterapia. Conservar regla general mínima de 15 años desde última atención, cinco en gestión y diez en central, y revisar excepciones conforme a Resolución 839 de 2017.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Autor de la atención	Registrar de manera oportuna, íntegra y autenticada.
Custodio	Controlar acceso, conservación, entrega y recuperación.
Apoyo administrativo	Acceder solo a datos necesarios según permiso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Verificar dos identificadores y buscar historia previa para evitar duplicados

Verificar dos identificadores y buscar historia previa para evitar duplicados. Abrir con fecha y hora, datos personales pertinentes, motivo, antecedentes, valoración, diagnóstico fisioterapéutico, objetivos y plan.

2. Registrar cada sesión de forma oportuna, clara y cronológica: estado inicial, técnica, reg

Registrar cada sesión de forma oportuna, clara y cronológica: estado inicial, técnica, región, parámetros reales, respuesta, educación, novedades y conducta. No llenar valores por defecto como si hubieran sido evaluados.

3. Identificar al autor mediante nombre, profesión y mecanismo de autenticación válido

Identificar al autor mediante nombre, profesión y mecanismo de autenticación válido. Esta edición no incorpora casillas de firma por la instrucción previa sobre formatos; antes de uso se debe integrar la firma o autenticación legalmente exigible. Nombre digitado o casilla aislada no bastan por sí solos.

4. Corregir con anotación trazable que conserva el original, fecha, razón y autor

Corregir con anotación trazable que conserva el original, fecha, razón y autor. No borrar, sustituir ni modificar el registro de otro profesional sin trazabilidad.

5. Custodiar en archivo protegido o sistema con cuentas individuales, permisos y registros de

Custodiar en archivo protegido o sistema con cuentas individuales, permisos y registros de acceso. Separar documentos administrativos de historia y anexar consentimientos, apoyos diagnósticos y comunicaciones clínicas pertinentes.

6. Facilitar acceso únicamente a titulares y personas o autoridades legitimadas, verificando

Facilitar acceso únicamente a titulares y personas o autoridades legitimadas, verificando fundamento. Conservar entrega de copias y restringir la evidencia de auditoría a acceso autorizado o muestra anonimizada.

7. Conservar según tabla aplicable, con transferencia, respaldo y recuperación probados

Conservar según tabla aplicable, con transferencia, respaldo y recuperación probados. No eliminar por cumplir un plazo sin procedimiento y requisitos; revisar excepciones y ausencia de obligaciones pendientes.

8. Al cerrar servicio designar custodio, canal y procedimiento de entrega

Al cerrar servicio designar custodio, canal y procedimiento de entrega. Mantener acceso y conservación sin abandonar archivos ni entregar información a terceros por simple solicitud verbal.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Cada atención registrada y autenticada.

Custodia y entrega trazables.

Conservación general y excepciones revisadas.

No usar el PDF en blanco como prueba de historia clínica completa.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.6 y 11.3.1.27-28: historia y registros; Resoluciones 1995/1999, 839/2017, Ley 1581/2012 y consentimiento conforme a Ley 528/1999 y reglas particulares.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente e identificación	
Fecha y hora	
Motivo y antecedentes	
Hallazgos y evaluación	
Diagnóstico y objetivos	
Plan y evolución	
Consentimiento y anexos	
Autor y autenticación	
Acceso o entrega	
Conservación y custodia	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autoría, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Datos sensibles

Ley 1581 de 2012, artículos 4-6, 8-12 y 17-18; Decreto 1074 de 2015, reglas de tratamiento. Información de salud y finalidades opcionales requieren análisis de base jurídica, autorización cuando exigible y seguridad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Ejercicio profesional

El presente documento es una plantilla para la adopción local y no debe ser utilizado como evidencia de la práctica profesional.

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576